

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE ACEPTACIÓN Y ACCIÓN II (AAQ-II)

Eje II: Procesos Psicológicos, Tercera Ola y Regulación • Evaluación Transdiagnóstica de Inflexibilidad Psicológica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Aceptación y Acción - II (AAQ-II).
Nombre Original (Inglés)	<i>Acceptance and Action Questionnaire – II (AAQ-II)</i>
Autores Originales	Drs. Frank W. Bond, Steven C. Hayes, Ruth A. Baer, et al. (2011).
Adaptación Española	Francisco J. Ruiz, Álvaro I. Langer, Carmen Luciano, Adolfo J. Cangas e Inmaculada Beltrán (2013).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo de Aceptación y Compromiso (ACT), constructo de Evitación Experiencial.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 7 reactivos con escala de respuesta Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde los 14 años). Aplicable en clínica ambulatoria, hospitalaria e investigación.
Tiempo de Administración	1 a 3 minutos en autoadministración; 3 a 5 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico de acceso abierto para fines clínicos y de investigación académica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TRANSDIAGNÓSTICO

El AAQ-II representa el instrumento de referencia internacional para operacionalizar el constructo de **inflexibilidad psicológica y evitación experiencial**, eje patogénico nuclear según la Teoría del Marco Relacional (RFT) y la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). La evitación experiencial se define como el patrón conductual caracterizado por la falta de disposición a entrar en contacto con experiencias privadas aversivas (emociones, pensamientos, sensaciones físicas, recuerdos) y los intentos deliberados de alterar su forma, frecuencia o contexto, aun a expensas de valores personales a largo plazo.

Neurobiológicamente, la inflexibilidad psicológica refleja una hiperreactividad del eje límbico (amígdala e ínsula anterior) asociada a un reclutamiento deficiente de los circuitos frontoestriales y prefrontales dorsolaterales que sostienen la regulación atencional y el control ejecutivo flexible. Al fusionarse cognitivamente con el malestar, el individuo restringe severamente su repertorio conductual. El AAQ-II predice transdiagnóticamente la vulnerabilidad a múltiples psicopatologías, incluyendo trastornos afectivos, de ansiedad, dolor crónico, adicciones y burnout laboral.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión del Hexaflex	Ítems	Rango Dir.	Manifestación Operativa y Fenomenológica
1. Fusión Cognitiva / Recuerdos	1 y 4	2 a 14	Impacto limitante de recuerdos dolorosos y memorias aversivas en el logro de una vida valiosa; sobreidentificación cognitiva.
2. Evitación Emocional	2 y 3	2 a 14	Miedo explícito a los propios sentimientos displacenteros y percepción de pérdida de control frente a las emociones.
3. Interferencia Conductual	5	1 a 7	Creencia imperativa de que los sentimientos difíciles impiden tomar acción efectiva en la vida personal y laboral.
4. Incompetencia Percibida	6 y 7	2 a 14	Juicio global de incompetencia emocional (“la mayoría de las personas manejan su vida mejor que yo”) y preocupaciones inmanejables.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.88 en muestra general comunitaria y 0.91 en muestra clínica ambulatoria (Ruiz et al., 2013). Fiabilidad test-retest a los 3 meses $r = 0.79$.
Estructura Factorial	El análisis factorial confirmatorio (AFC) ratifica de manera inequívoca la solución unifactorial (RMSEA = 0.046, CFI = 0.988), demostrando invarianza métrica entre sexos y edades.
Validez Concurrente y Divergente	Correlaciones directas robustas con síntomas depresivos (BDI-II, $r = 0.68$), ansiedad (BAI, $r = 0.65$) y estrés percibido (PSS, $r = 0.62$); e inversa con satisfacción vital (SWLS, $r = -0.58$).
Sensibilidad al Cambio	Altamente sensible a los efectos terapéuticos de intervenciones basadas en aceptación (ACT) y mindfulness, exhibiendo tamaños de efecto d de Cohen > 0.80 postratamiento.
Validez Incremental	Predice varianza significativa en sintomatología psicosomática y ausentismo laboral más allá de las medidas clásicas de afecto negativo y neuroticismo.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada ítem se califica mediante una escala ordinal de 7 anclajes: **1** = «Nunca es verdad», **2** = «Muy rara vez es verdad», **3** = «Rara vez es verdad», **4** = «A veces es verdad», **5** = «A menudo es verdad», **6** = «Casi siempre es verdad», **7** = «Siempre es verdad».

- **Puntuación Directa Total:** Suma lineal simple de los 7 reactivos (ítems 1 al 7). No contiene ítems invertidos.
- **Rango Teórico: 7 a 49 puntos.** A mayor puntuación, mayor nivel de inflexibilidad psicológica y evitación experiencial.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA, BAREMOS Y PUNTOS DE CORTE

Estratificación	Rango	Estado Psicológico	Implicación Clínica y Terapéutica
Baja Inflexibilidad	7 a 19	Flexibilidad psicológica funcional	Aceptación adecuada del malestar emocional habitual. Capacidad para perseverar en conductas orientadas a metas y valores.
Moderada	20 a 24	Inflexibilidad subclínica o limítrofe	Riesgo de estancamiento conductual ante episodios de estrés agudo. Indicación de intervenciones preventivas en defusión.
Alta	25 a 28	Inflexibilidad clínica significativa	Patrón evidente de evitación vivencial; sufrimiento derivado de la lucha contra síntomas ansiosos o depresivos. Terapia ACT recomendada.
Severa / Extrema	29 a 49	Inflexibilidad psicológica extrema	Fusión cognitiva generalizada y parálisis conductual severa. Alto riesgo de comorbilidad psiquiátrica crónica y discapacidad funcional.

PUNTOS DE CORTE DIAGNÓSTICO EN POBLACIÓN ESPAÑOLA (Ruiz et al., 2013):

El punto de corte de **≥ 24 puntos** discrimina eficazmente entre población general y clínica con una sensibilidad del 82% y especificidad del 79%. Una puntuación de **≥ 28 puntos** (percentil 85 en población clínica) identifica una rigidez cognitiva severa que perpetúa síndromes del Eje I y bloquea el aprendizaje adaptativo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y ABORDAJE ACT

GUÍA DE INTERVENCIÓN MODULAR SEGÚN EL NIVEL DEL AAQ-II:

- **Puntuación < 20:** Foco en clarificación de valores y potenciación de hábitos vitales de crecimiento. No requiere protocolo formal de reducción de evitación.
- **Puntuación 20 - 24:** Evaluar disparadores de control emocional. Introducir metáforas de aceptación (ej. "el autobús y los pasajeros") y ejercicios breves de defusión cognitiva.
- **Puntuación >= 25:** Iniciar protocolo formal de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Trabajar desesperanza creativa para dismantlar la agenda de control ineficaz, fomentar la disposición a sentir el malestar y orientar acciones comprometidas. Monitorear retest cada 4 semanas; una reducción de >= 7 puntos denota flexibilización clínica significativa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DOLOR CRÓNICO Y DEPRESIÓN

Paciente: Varón de 44 años, programador informático, derivado por Trastorno Depresivo Persistente y fibromialgia refractaria. Ha abandonado actividades sociales y de ocio familiar esperando que «el dolor y la fatiga desaparezcan para poder vivir».

Evaluación Cuantitativa Inicial: AAQ-II = **37 puntos** (Severidad extrema; percentil 95 clínico). Desglose crítico: Ítem 1 = 6, Ítem 2 = 6, Ítem 3 = 5, Ítem 4 = 5, Ítem 5 = 6 («Mis emociones me impiden actuar»), Ítem 6 = 5, Ítem 7 = 4.

Formulación Clínica: El paciente presenta una severa trampa de evitación experiencial. Interpreta las sensaciones somáticas como barreras absolutas para la acción, cayendo en aislamiento y rumiación que amplifican la experiencia del dolor.

Tratamiento y Evolución: Se aplicó protocolo ACT de 12 sesiones focalizado en aceptación somática, defusión de reglas verbales sobre el rendimiento corporal y activación de valores paternos y profesionales. Al cierre, el AAQ-II descendió a **19 puntos** (cambio clínicamente significativo de 18 puntos), logrando reanudar actividades recreativas con sus hijos con mantenimiento de la mejoría a los 6 meses.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CRÍTICA METODOLÓGICA Y SOLAPAMIENTO DE SÍNTOMAS

Investigaciones recientes señalan que el AAQ-II puede medir tanto rigidez psicológica como afecto negativo general o distress neurótico. En presencia de puntuaciones muy elevadas, triangular siempre con medidas de sintomatología clínica del Eje I (PHQ-9, GAD-7) e instrumentos de flexibilidad positiva (como Psy-Flex).

RIESGO AUTOLÍTICO Y FUSIÓN COGNITIVA

Una puntuación en AAQ-II >= 35 con respuesta máxima en el ítem 1 y 5 asociada a ideación de muerte indica que el paciente percibe el suicidio como la única forma radical de evitación experiencial definitiva. Exige despistaje de riesgo autolítico inmediato.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. *Behavior Therapy*, 42(4), 676–688.
2. Ruiz, F. J., Langer, A. I., Luciano, C., Cangas, A. J., & Beltrán, I. (2013). Measuring experiential avoidance and psychological inflexibility: the Spanish version of the Acceptance and Action Questionnaire-II. *Psicothema*, 25(1), 123–129.
3. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. *Behaviour Research and Therapy*, 44(1), 1–25.
4. Rochefort, C., Baldwin, A. S., & Chmielewski, M. (2018). Experiential avoidance: An examination of the construct validity of the AAQ-II and MEAQ. *Behavior Therapy*, 49(3), 435–449.